

03 - 03- Grossesse Extra-Utérine (GEU) - Pr. SOUMMANI

Bonjour, nous allons étudier aujourd'hui un chapitre fort intéressant, puisque c'est une urgence chirurgicale ou médicale, c'est la grossesse extra-utérine. La grossesse extra-utérine, appelée également grossesse ectopique, est une nidation ectopique de l'œuf en dehors de la cavité utérine. La localisation la plus fréquente est la localisation tubaire, c'est-à-dire au niveau de la trompe de femme.

Le facteur de risque principal est les infections sexuellement transmissibles. Si vous faites votre diagnostic précocement, vous allez non seulement éviter les complications, mais également vous aurez la possibilité de faire un traitement conservateur moins invasif. La stéréoscopie a un intérêt à la fois diagnostique que thérapeutique.

Non diagnostiqué tôt, la grossesse extra-utérine peut être grave pour la patiente. Le pronostic actuel est surtout lié à la fertilité ultérieure. Dans ce chapitre, les objectifs sont connaître les facteurs de risque de la grossesse extra-utérine, l'évolution et les différentes localisations, connaître le diagnostic et les formes cliniques de la grossesse extra-utérine, connaître les moyens thérapeutiques et ses indications.

Sur le plan épidémiologique, la fréquence de la grossesse extra-utérine est environ 1,5 à 2 % des grossesses. 14 000 nouveaux cas sont diagnostiqués en France. L'âge maternel, en général, le risque de la grossesse extra-utérine augmente avec l'âge.

1,4 % à 21 ans, tandis qu'après 60 ans, la fréquence est supérieure à 6 % des cas. Voilà une courbe qui va montrer qu'il y a une augmentation en fonction de l'âge. Les facteurs favorisants, il y en a deux types.

Il y a des facteurs traumatiques tubaires qui sont provoqués soit par des salpingites, soit par les antécédents de la grossesse extra-utérine, soit des antécédents de la chirurgie tubaire, des antécédents d'une chirurgie adhésive, les endométrioses et la compression extrinsèque, soit par un kyste ou par une tumeur ovarienne. Mais également, le facteur de risque peut être un ralentissement de l'œuf dans la trompe, c'est-à-dire lors de la migration de l'œuf vers la cavité utérine, il va se ralentir et il va augmenter de volume, et par conséquent, au lieu que l'implantation se fasse au niveau de la cavité utérine, il va se faire au niveau de la trompe de fallop. Ceci peut être dû soit au tabac, au microprogestatif, à des malformations liées à une exposition à la stilbestrol, appelée diéthylstilbène, soit lors de l'assistance médicale à la procréation, ou lors de l'existence d'un dispositif intra-utérin.

Sur le plan anatomopathologique, la localisation des grossesses extra-utérines la plus fréquente est la localisation tubaire, environ 95% des cas, surtout au niveau de l'ampoule, c'est-à-dire la grossesse ampullaire, suivie par la grossesse isthmique au niveau de l'isthme tubaire, puis au niveau pavillonnaire, au niveau du pavillon, 5% des cas. Il y a également les grossesses cornéales, il y a

les grossesses abdominales, il y a les grossesses ovariennes et les grossesses cervicales. Sur ce schéma, on voit les différents types de grossesses extra-utérines.

L'évolution de la grossesse extra-utérine se fait principalement par un avortement tumeur. Ça veut dire, puisque l'œuf est fait sanitation dans un milieu qui est inapproprié, c'est-à-dire la trombe des phallos et non pas la cavité de l'utérus, donc avec l'augmentation du volume, il va se décoller et il va être expulsé. Cette expulsion peut se faire soit vers l'abdomen, et on a ce qu'on appelle l'avortement tubo-abdominal, soit vers l'utérus et on va avoir l'avortement tubo-utérin, qui va en général se manifester comme une fausse couche.

Parfois, surtout au niveau ismique et au niveau interstitiel, la grossesse extra-utérine peut se remplir et créer ce qu'on appelle l'hémopéritoine, ça veut dire du sang au niveau de la cavité abdominale. Le cas particulier est celui de la grossesse abdominale, qui peut évoluer jusqu'à un avancé de la grossesse. Nous allons prendre pour l'étude clinique un type de description qui est la GU tuber.

A l'interrogatoire, c'est une patiente qui est en période d'activité génitale, c'est une patiente qui présente un ou plusieurs facteurs de risque de la grossesse extra-utérine et qui va se présenter pour soit un retard des règles ou une amputation. Soit des douleurs pelviennes, ces douleurs pelviennes sont d'intensité variable, ça peut être des douleurs discrètes, comme ça peut être des douleurs aiguës à caractère syncopale. Ce sont des douleurs qui sont intermittentes avec des paroxysmes.

Ces douleurs sont localisées au niveau du pelvis ou bien au niveau du fossiliac, droite ou gauche, en fonction de la localisation de la grossesse extra-utérine, mais qui irradient vers tout l'abdomen et surtout, ils ont une irradiation scapulaire droite qui est très évocatrice de la grossesse extra-utérine. Après les douleurs, il y a les métroragies, ça veut dire un saignement qui provient de la cavité utérine. C'est un saignement qui est fait de sang noirâtre, appelé sépia.

Ce sont des métroragies qui sont intermittentes. Le plus souvent, ce sont des métroragies qui sont discrètes, c'est-à-dire des petites gouttelettes, et qui n'expliquent pas l'état général de la patiente qui peut être altérée sur le plan hémodynamique. Parfois, les métroragies sont abondantes et s'accompagnent de l'émission de la caduque utérine, c'est-à-dire ce qui reste de l'endomètre.

Parfois, la femme va présenter des signes sympathiques de grossesse, à savoir les nausées, les vomissements, des seins tendus. Donc, ce sont les signes classiques d'une grossesse. Parfois, si la femme saigne dans l'abdomen, vous aurez des vertiges, des lipotimées, qui sont des signes de gravité de la pathologie.

À l'examen clinique, qu'il faut le faire vis-et-rectum vide, d'abord, il faut, bien sûr, parce que c'est une pathologie hémorragique, donc il faut aller chercher la pression artérielle, le cou, les conjonctives, la coloration des conjonctives, pour chercher une anémie. Puis, on va mettre notre

spéculum, alors, pour voir d'abord l'état du col. En général, c'est un col qui est gravidé, c'est un col qui est rougeâtre ou violacé.

On appelle col couleur lila. C'est un col qui est fermé. Il n'y a pas de glaire.

C'est un col qui peut être latérodévié, du côté contralatéral de la localisation de la grossesse extra-utérine. Et vous allez voir que le sang provient de l'intérieur de l'utérus, c'est-à-dire qu'il est d'origine endocervicale. Le toucher vaginal, toujours couplé par le palpé abdominal, va trouver un utérus gravidé.

C'est un utérus globuleux, mais qui n'est pas augmenté de volume. Ou bien, il est un peu volumineux, mais moins que nous le voudrions, le terme de la grossesse. Ça veut dire, par exemple, si vous avez une grossesse de 8-9 semaines d'améliorée, le volume de l'utérus ne dépasse guère les 5-6 semaines d'améliorée.

Le toucher vaginal peut révéler une masse latéro-utérine de consistance mollasse, qui est mal limitée et qui est douloureuse à la mobilisation. Parfois, vous n'allez pas trouver de masse latéro-utérine, mais seulement un petit empattement au niveau du cul de sac vaginal, qui est moins sensible que le cul de sac du côté contralatéral. Si vous faites un toucher au niveau du doublet, vous allez réveiller une douleur importante, le cul de doublet comme celui décrit dans les Péritonites.

À la mobilisation de l'utérus, vous allez réveiller une douleur très importante. Mais, parfois, l'examen clinique est tout à fait normal. Au total, c'est une patiente en période d'activité génitale, c'est une patiente présentant un ou plusieurs facteurs de risque qui va se présenter pour un retard de règles, pour des douleurs pelvières, pour des météoragies, avec des signes sympathiques de grossesse.

Et à l'examen, vous allez trouver un empattement d'un cul de sac, un utérus qui n'est pas augmenté de volume, ou un peu, mais moins que le voudrait, l'âge gestationnel. Vous allez trouver, parfois, si vous avez de la chance, une masse latérale utérine et un cri de doublet. Même si l'examen physique est tout à fait normal, vous ne pouvez pas éliminer une grossesse extra-utérine, d'où l'apport des examens complémentaires.

D'abord, le dosage biologique plasmatique des bêta-HSG, c'est-à-dire la fraction bêta de l'hormone chorionique gonadotrope. Les bêta-HSG se positivent au 11^e jour postovulatoire, c'est-à-dire avant la survenue des règles, et commencent à doubler toutes les 48 heures. C'est-à-dire que l'intérêt d'un diagnostic préconçu par cet examen.

Mais les bêta-HSG vont vous montrer que l'utérus est gravidé, que la femme est enceinte, mais ils ne peuvent en aucun cas vous dire que c'est une grossesse intra- ou extra-utérine, d'où l'intérêt de l'étude de la courbe des taux de bêta-HSG, c'est-à-dire la cinétique de bêta-HSG. Voilà, en général, les bêta-HSG qui se positivent dans le sang à partir de G10, dans les urines à

partir de J24. Donc, si vous demandez, demandez les bêta-HSG.

Il faut savoir que pour faire un diagnostic d'une grossesse normale, vous n'avez pas besoin de bêta-HSG plasmatique, seuls les bêta-HSG urinaires suffisent. Mais lorsque la grossesse est anormale, à savoir fausse-grosse ou grossesse arrêtée, à savoir grossesse molaire, à savoir grossesse ectopique, c'est dans ce cas où on a à demander le taux de bêta-HSG plasmatique. Après l'examen biologique de bêta-HSG, c'est l'échographie pelvienne qui a un intérêt énorme dans le diagnostic de la grossesse extra-utérine.

Elle peut se faire par voie abdominale ou par voie endovaginale. Il faut dire que la femme est sensible à cet examen parce qu'elle a une douleur pelvienne. L'échographie ne peut s'interpréter qu'en corrélation avec l'âge gestationnel.

Parce que le sac gestationnel n'est visible à l'échographie à partir de la cinquième semaine d'améliorée. Par conséquent, si vous faites votre examen avant la cinquième semaine, vous allez trouver un utérus qui est vide. C'est pour ça qu'il faut coupler les bêta-HSG avec l'échographie pelvienne.

En général, le sac gestationnel est visible lorsque le taux de bêta-HSG est supérieur à 1 000 ou 1 500 unités internationales par litre. Donc, si vous avez un utérus vide, ce qu'on appelle la vacuité utérine, si vous avez cette vacuité utérine avec un taux de bêta-HSG supérieur à 1 000 ou 1 500 unités, la grossesse extra-utérine est très probable. A l'échographie, parfois, vous pouvez trouver une image lacunaire, anécogène ou hypoécogène à l'intérieur de l'utérus.

Il faut faire attention, ce n'est pas un sac gestationnel, mais c'est un pseudo-sac gestationnel. Ses caractéristiques échographiques sont, d'abord, il est centré dans la cavité utérine et il n'est pas entouré par la couronne trophoblastique. C'est une image écogène qui, en général, entoure le sac gestationnel.

Par contre, le vrai sac gestationnel, il est à l'intérieur de l'utérus, mais il est excentré et il est entouré par une couronne trophoblastique. D'autres signes échographiques, c'est d'abord un épanchement liquidien dans le douglas, ça veut dire que c'est du son dans le douglas. En général, vous allez le voir à l'échographie comme une zone anécogène ou hétérogène lorsque le son est coagulé, rétro-utérine.

Si vous avez de la chance, vous pouvez trouver une formation hétérogène, tatero-utérine, qui y est d'hématosalpinx, ça veut dire du son au niveau de la trompe. Si vous avez plus de chance, vous allez trouver un sac ovulaire extra-utérin avec une activité cardiaque. De toutes les manières, lorsque le taux de bêta-HSG est inférieur à 1 000 unités internationales par litre, vous n'allez pas pouvoir voir le sac gestationnel, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'utérus.

Il faut attendre 48 heures pour refaire l'examen clinique, l'examen l'échographie, et demander le taux de bêta-HSG. Voilà un pseudo-sac gestationnel. Vous voyez très bien qu'il est au centre de

la cavité utérine et qu'il n'est pas entouré par la courante trophoblastique.

Ici, par contre, c'est insénuément. Ici, c'est un sac gestationnel qui est oblong. C'est un mauvais sac gestationnel.

C'est probablement une grossesse AVT. Par contre, on voit à gauche un utérus avec une ligne remplie de caducs. Et en latéraux utérins, on voit un sac gestationnel avec un embryon, avec une vesicule vitéline, entourée par la courante trophoblastique.

Il faut faire attention, parce que parfois ce n'est pas une grossesse extra-utérine, mais c'est seulement un utérus bicorne et une de ses cornes abrite le sac gestationnel. À droite, vous voyez très bien l'utérus. Et en arrière de l'utérus, il y a une zone anécogène qui correspond à l'hémopéritoire.

D'autres examens complémentaires, vous allez les demander. C'est une pathologie hémorragique, donc vous devez demander un groupe à sanguins avec régis. Vous devez demander un hémogramme pour voir s'il y a un anonyme.

Vous devez demander l'avis des anesthésistes réanimateurs si un geste chirurgical est indiqué, ou bien un bilan préthérapeutique si vous aurez besoin d'un traitement médical. Au total, souvent le diagnostic de la grossesse extra-utérine repose sur la clinique, sur l'échographie pelvienne et sur le taux de bêtas séchées. Parfois, malgré ces trois examens, le doute persiste.

Dans ce cas, une sélioscopie à visée diagnostique doit être réalisée. Voilà ce que vous allez voir par la sélioscopie. On voit un hématosalpinx, l'utérus, l'ovaire et l'hématosalpinx, c'est-à-dire la trompe remplie de sang.

Voilà un hémopéritoire, c'est du sang dans le cul du sac de Douglas, en arrière de l'utérus. Et à gauche, vous avez l'hématosalpinx. Donc voilà le tripied clinique qui peut être asymptomatique quand ça peut être un état de choc hémorragique, les bêtas asséchées plasmatiques quantitatives et l'échographie pelvienne.

La grossesse extra-utérine est connue par le fait qu'il peut avoir plusieurs formes cliniques. La forme qu'on a étudiée ne présente que 50% des cas. Les autres cas peuvent être soit des formes symptomatiques, à savoir la forme pseudo-abortive, c'est-à-dire la patiente va consulter beaucoup plus pour un tableau d'avortement, donc des métrorragies faites de sang rouge abondant avec élimination de la canuque.

Mais dans ce cas, si vous demandez les bêtas asséchées, en cas de fausse couche, les bêtas asséchées diminuent. Par contre, dans la grossesse extra-utérine, les bêtas asséchées soit stagner, soit le taux augmente. Et si vous faites un examen anatomopathologique du produit d'expulsion, vous n'allez pas trouver des villosités coréales qui diagnostiquent la grossesse.

Il y a également la forme fébrile. La forme fébrile, c'est un tableau de serpent GIGU avec une

fièvre 38, 38, 5, 39, une accélération de la vitesse de sédimentation, une hyperglucositeuse. Le dosage de bêtas asséchées qu'il faut faire chaque fois qu'il y ait des douleurs, qu'il y ait des métroragies, qu'il y ait un retard de règles, vous allez trouver que la femme est enceinte et conséquent, vous allez suspecter la grossesse extra-utérine.

Il y a des formes qui sont possy-symptomatiques. Ça veut dire que vous n'allez pas trouver tous les symptômes. Et c'est pratiquement toujours le cas.

Soit la femme va se présenter uniquement pour un retard de règles, soit il va se présenter uniquement pour la douleur pelvienne ou pour des métroragies. Donc, chaque fois qu'il y a une patiente en période d'activité génitale qui se présente en consultation ou aux urgences pour une symptomatologie pelvienne, quelle que soit cette symptomatologie, il faut penser à la grossesse extra-utérine et demander un taux de bêtas asséchées. Il y a également l'association de grossesse intra-utérine avec la grossesse extra-utérine.

Et dans ce cas, l'apport de bêtas asséchées va être peu productif puisqu'il sera positif que ce soit dans la grossesse intra-utérine ou la grossesse extra-utérine. Malheureusement, c'est les cas où ils peuvent évoluer vers la rupture de la trompe. Il y a également la grossesse hétérotopique.

Ils sont rares, certes, mais ils se voient de plus en plus lors de l'assistance médicale à la procréation, surtout la fréquentation in vitro. Les formes évolutives. D'abord, l'inondation péritoniale.

Elle est due à une rupture d'une grossesse extra-utérine. Le plus souvent, c'est la localisation interstitiale ou isthmique qui se rend précocement. Il va s'accompagner d'un état de choc hémorragique avec des signes d'épongement péritonial, défense, cri de douleur, etc.

Il faut réanimer la femme et il faut commencer en urgence un traitement chirurgical. Parfois, le saignement se fait à l'intérieur de l'abdomen, mais c'est un saignement qui est chronique. Donc, c'est un saignement qui se fait à bas bruit.

Le son va s'abriter au niveau du cul de sac de Douglas. Il va s'organiser sous forme d'une masse qui va combler le Douglas. Vous allez trouver des signes de compression digestive, des signes de compression urinaire.

Vous allez trouver une anémie et une douleur abdominale. Dans ce cas, puisque c'est chronique, le taux de bêta peut être négatif. Il y a des formes qui évoluent vers la régression, vers l'évolution, c'est-à-dire la grossesse disparaît d'elle-même.

Et c'est dans ces cas où une abstention thérapeutique avec une surveillance est de mise. Les objectifs thérapeutiques sont d'abord, il faut assurer les moustaches parce que la femme saigne. Deuxièmement, il faut supprimer la grossesse extra-utérine parce que tant que la grossesse est en place, la femme va saigner.

Il faut surtout penser à la fertilité ultérieure. Donc, il faut être... Les moyens thérapeutiques sont d'abord l'abstention et la surveillance puisqu'on a dit qu'il y a des formes qui régressent, qui involuent. Donc, vous pouvez vous abstenir et surveiller.

Ça ne se conçoit que dans un milieu hospitalier. Le traitement chirurgical peut se faire soit par sérieuse chirurgie, le plus souvent c'est le cas, rarement par l'aparotomie, surtout s'il y a une rupture de la treme et un état de choc hémorragique. Le traitement de choix, c'est un traitement conservateur, c'est-à-dire ouvrir la treme, enlever l'embryon, le trophoblaste, faire les moustaches, surveiller par la suite.

Parfois, le traitement doit être radical, mais ça ne doit pas être la règle. Le traitement médical repose sur le méthotrexate qui peut se faire au cours de la celluloscopie. Vous mettez le méthotrexate sur le site, ça donne des bons résultats.

Mais parfois, ça se fait par voie générale si vous n'avez pas fait de celluloscopie. Un milligramme par kilo, une seule injection, il est efficace. Les bêtises de gestion négative, en général au bout d'un mois, il faut s'attendre à une augmentation après l'injection du méthotrexate au début, mais après, ça va diminuer.

Mais il doit se faire en hospitalisant la femme et en surveillant la femme. Le traitement médical est indiqué chaque fois que la grossesse extra-utérine est peu évolutive, c'est-à-dire que les bêtas ACG sont inférieures à 5000. Lorsque le diagnostic est évident, en échographie vaginale, lorsque la grossesse extra-utérine n'est pas embryonnée et lorsqu'il n'y a pas ou il y a peu dépensement dans le doublet, et lorsque la surveillance est possible.

Attention, si la femme est résus négative, il ne faut pas oublier d'injecter le sérum anti-D. L'abstention thérapeutique avec surveillance en milieu hospitalier est indiquée lorsque la grossesse extra-utérine avec un taux de bêtas ACG inférieur à 1000 unités par litre est lorsque la surveillance est possible. La chirurgie est indiquée lorsque la grossesse extra-utérine est évolutive, lorsque le saignement est important.

Toujours faire un traitement conservateur. Le traitement radical ne se conçoit que lorsque la grossesse extra-utérine est récidivant, c'est-à-dire la femme a fait une première grossesse extra-utérine, on a fait le traitement conservateur, et puis elle a refait sur la même treme une récidive. Dans ce cas, vous devez faire une salpingectomie, c'est-à-dire enlever toute la treme.

Mais également, la chirurgie radicale, la salpingectomie, est indiquée lorsque l'indication est illusoire, ça veut dire que la femme est multipare, elle a fait une treme qui peut être le siège d'une éventuelle récidive de grossesse extra-utérine. Ou bien la salpingectomie est indiquée lorsque vous opérez la femme et vous ne pouvez pas conserver lors d'un éclatement de la treme, lors de la rupture tubaire. Dans les autres situations intermédiaires, c'est au staff qui va étudier, au staff médical qui va étudier ces indications.

Donc en conclusion, il faut savoir s'abstenir, mais surveiller et hospitaliser la femme. Vous pouvez faire un traitement médical à base de méthodes comme vous pouvez traiter chirurgicalement. La règle dans le traitement chirurgical, c'est de conserver la trompe.

Quelques cas qui nécessiteraient une chirurgie radicale, à savoir une salpingectomie. Après le traitement chirurgical radical, le taux de grossesse intra-utérine avoisine les 50 %. Mais il faut savoir que la grossesse extra-utérine, le risque de grossesse extra-utérine contre latérale est important, presque 15 % des cas. Après le traitement conservateur, environ 60 % de grossesse intra-utérine.

Mais c'est en fonction des antécédents de la patiente s'il a une bonne trompe du côté opposé ou non. Donc la règle, à chaque fois que vous traitez les patients présentant une grossesse extra-utérine, ils doivent être avertis à la sortie qu'il y a un risque élevé de récurrence. En conclusion, c'est une urgence médicale ou une urgence chirurgicale.

Il est assez fréquent. Elle augmente avec l'âge. Elle augmente avec les infections sexuellement transmissibles.

Elle peut revêtir plusieurs aspects. La forme typique n'est présente que dans pratiquement 50 %. Donc faites attention. Et je répète encore une fois, chaque fois qu'une patiente en période d'activité génitale ou qu'une pathologie survient, quelle que soit sa symptomatologie, n'oubliez pas de demander un taux de bêta asséché.

Et merci.